



ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA PRIMEIROS SOCORROS



**INSTITUTO
FEDERAL**
Minas Gerais

Campus
BambuÍ

ORIENTAÇÕES BÁSICAS PARA PRIMEIROS SOCORROS

**Cartilha destinada à comunidade com procedimentos
básicos de primeiros socorros**

Volume 1

Regiane Maria Soares Ramos

Márcio Reis Costa

2021





Distribuição gratuita. Obra sem fins lucrativos. Não há direitos reservados. A reprodução está autorizada, no todo ou em parte, desde que a obra original seja devidamente referenciada.

Coordenação: Regiane Maria Soares Ramos

Diagramação: Fábio Júnior Diniz

Contato: regiane.ramos@ifmg.edu.br

Catálogo na Fonte Biblioteca IFMG - Campus Bambuí

R175o Ramos, Regiane Maria.

Orientações básicas para primeiros socorros: cartilha destinada à comunidade interna e externa com procedimentos básicos de primeiros socorros: volume 1 [recurso eletrônico] / Regiane Maria Soares Ramos, Márcio Reis Costa. – Bambuí: Instituto Federal de Minas Gerais, 2021.

28 p.

E-book, no formato PDF.

ISBN 9786500360059

1. Primeiros socorros. I. Costa, Márcio Reis. II. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais – *Campus* Bambuí. III. Título.

CDD 616.0252

Catálogo: Meriely Ferreira de Almeida - CRB-6/2760

SUMÁRIO

1. Apresentação	05
2. Números importantes	07
3. Pequenos ferimentos (escoriações)	08
4. Controle de pequenas hemorragias externas	09
5. Sangramento no nariz	10
6. Desmaio	11
7. Crise convulsiva	12
8. Queimaduras	13
9. Envenenamento e Intoxicações	14
10. Engasgo e asfixia	16
11. Suspeita de fratura, luxação ou entorse	17
12. Distensão muscular (estiramento muscular)	20
13. Câibras	21
14. Traumas por quedas	22
15. Acidentes por animais peçonhentos	23
16. Mordida de animais	24
17. Referências Bibliográficas	25

1. Apresentação

O IFMG *campus* Bambuí conta com um amplo espaço (área total de 328,76 hectares e cerca de 40 mil metros quadrados de construções) e oferece vários cursos a nível técnico (Ensino Médio Integrado e Subsequente) e superior (áreas humanas, exatas e biológicas) para mais de 2 mil alunos e possui um corpo docente composto por 143 professores, além de 138 servidores da área administrativa e 82 trabalhadores terceirizados¹. O *campus* se configura como ambiente escolar, de trabalho e até mesmo doméstico, pois pode acomodar até 248 estudantes nos alojamentos da Moradia Estudantil e um Restaurante Universitário que oferece até 1.000 refeições diárias.

O Instituto possui características de uma fazenda, com ampla área verde e de plantio, animais silvestres e de pastagens e, ao mesmo tempo, possui laboratórios e equipamentos com alta tecnologia para atender as mais diversas áreas. Além disso, o *campus* possui amplos espaços para a prática de atividades físicas como: ginásio poliesportivo, quadras externas, campo de futebol, piscina semiolímpica, academia de musculação, anfiteatro, salão de dança e de jogos, além da ciclovia que liga a cidade ao *campus* (aproximadamente 2km de extensão).

Diante desta complexidade de ambientes, mesmo com a adoção de estratégias de segurança preventivas, o *campus* Bambuí não está isento da ocorrência de acidentes, pois são acontecimentos fortuitos e inesperados.

Diante disso, a Cartilha “Orientações Básicas Para Primeiros Socorros” foi elaborada com a finalidade de informar os procedimentos básicos de primeiros socorros embasados nos tipos de acidentes mais corriqueiros no *Campus* Bambuí, a fim de preparar a comunidade para atuar na primeira abordagem de um acidente, prestar cuidados iniciais até a chegada do atendimento e/ou transporte ao serviço especializado e evitar medidas precipitadas que possam agravar a situação ou até mesmo colocar em risco a vida de um acidentado.

A cartilha, que reproduz técnicas simples e já conhecidas, não tem a finalidade de formar socorristas. É um material com informações técnicas básicas sobre primeiros socorros elaborado pelo Técnico em Enfermagem responsável pelo Setor-ambulatorial da Coordenadoria de Assuntos Estudantis e pela Docente de Educação Física responsável pela Supervisão do Serviço de Apoio ao Esporte e Lazer do *campus* Bambuí.

Após vários anos de atuação no *campus* e da experiência profissional de ambos, foi possível constatar que a maioria das pessoas não tem conhecimento sobre procedimentos básicos de primeiros socorros ou utilizam informações adquiridas pelo senso comum, muitas vezes equivocadas, que podem agravar situações corriqueiras

¹ Disponível em: <https://www.bambui.ifmg.edu.br/portal/a-instituicao>

como: picadas de insetos, queimaduras, feridas, distensões ou até mesmo fraturas. Como o campus é muito grande e possui uma complexidade de ambientes, surgiu a ideia de criar esta cartilha.

Os tipos de acidentes abordados nesta cartilha são: Pequenos ferimentos (escoriações); Controle de pequenas hemorragias; sangramento no nariz; Desmaio; Crise convulsiva; Queimaduras; Envenenamento e intoxicações; Engasgo e asfixia; Suspeita de fratura, luxação, entorse; Distensão muscular; Cãibras; Acidentes por animais peçonhentos e mordida de animais. A cartilha também informa números de telefone para emergência, como, o ramal do Ambulatório Médico do *campus*, da Coordenadoria de Assuntos Estudantis, o Samu, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar da cidade de Bambuí.

Buscou-se abordar cada acidente citado anteriormente de maneira pontual e de fácil entendimento e execução. Portanto, em cada acidente foi indicado o seguinte roteiro: causas, sinais e sintomas, o que fazer (conduta), o que não fazer e para onde encaminhar. Dessa forma o conteúdo da cartilha possibilita, também, sua utilização em outros locais para além do *campus*, como em outras escolas e no ambiente doméstico familiar, por exemplo.

É importante destacar que não é pretensão dos organizadores que esta cartilha seja por si só um instrumento capaz de resolver todos os problemas dos muitos e variados acidentes possíveis no *campus*, mas ainda que ela seja uma única fonte de informações pronta, é certamente incompleta e necessitará de frequentes atualizações e revisões.

Ao editar esta cartilha, o IFMG campus Bambuí reafirma o seu compromisso com as ações de promoção e proteção da saúde de todos os estudantes, servidores e comunidade externa desta Instituição.

Márcio Reis Costa
Regiane M. Soares Ramos.

2. Números importantes

SAMU – 192

AMBULATÓRIO MÉDICO CAMPUS BAMBUÍ – 4952

COORDENADORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - 4916

BOMBEIROS – 193

POLICIA MILITAR – 190 ou (37) 3431-1190

3. Pequenos ferimentos (escoriações)

Causas: Pode ser ocasionado por diversos fatores, tais como, facas, objetos perfuro-cortantes, quedas, etc.

Sinais e sintomas: Lesão na pele com sangramento ou não.

O que fazer (Conduta):

- Manter a calma e tranquilizar a vítima;
- afastar os curiosos;
- se a região estiver suja, lave o ferimento com água corrente e sabão ou limpe suavemente em volta do ferimento com um pano macio.
- proteger provisoriamente a ferida com uma compressa, gaze ou pano limpo.

O que não fazer: Nunca aplicar borra de café, sal, açúcar ou qualquer outro produto no ferimento.

Para onde encaminhar: Se necessário encaminhar para o Ambulatório Médico do Campus ou Serviço de Saúde mais próximo para avaliação e curativo adequado.

4. Controle de pequenas hemorragias externas

Causas: Ferimentos ou lesões com sangramentos externos visíveis observados durante a avaliação inicial.

Sinais e sintomas: Sangramento externo visível e de fácil identificação;

O que fazer (Conduta):

- Manter a calma e tranquilizar a vítima;
- Afastar os curiosos;
- Se possível, lavar as mãos e calçar luvas descartáveis;
- Identificar o local do sangramento;
- Lavar com água corrente e sabão;
- Aplicar gazes, compressa ou pano limpo diretamente sobre o ferimento;
- Aplicar compressão manual direta sobre o ferimento (a pressão deve ser mantida até que o sangramento pare);
- Proteger provisoriamente a ferida com uma compressa, gaze ou pano limpo;
- Elevar o membro, caso seja hemorragia em membros superiores ou inferiores;
- Aplicar compressa fria também para reduzir a hemorragia.

O que não fazer:

- Nunca use borra de café, sal, açúcar ou qualquer outro produto para “estancar” a hemorragia.
- Caso haja indícios de sangramento sob o curativo, não remover a atadura ou bandagem encharcada de sangue, aplique um novo curativo sobre o primeiro exercendo maior pressão manual.
- NÃO encoste no sangue do acidentado sem proteção nas mãos.
- NÃO elevar membro em caso de fratura.

Para onde encaminhar: Se necessário encaminhar para o Ambulatório Médico do Campus ou Serviço de Saúde mais próximo para avaliação e curativo adequado.

Importante: Não remover objetos encravados. Nesse caso, a pressão deve ser aplicada em um dos lados do objeto.

Quando o objeto que causou o acidente estiver sujo ou enferrujado, caso a carteira de vacinação não esteja em dia, será necessária a vacina antitetânica, que pode ser aplicada em hospitais ou postos de saúde.

5. Sangramento no nariz

Causas: Introdução de corpo estranho em cavidade nasal; uso de medicações anticoagulantes; rompimento de vasos sanguíneos do nariz.

Sinais e sintomas: Dor local, sangramento pelas narinas.

O que fazer (Conduta):

- Acalmar a vítima e colocá-la sentada com o tronco e a cabeça eretos ou levemente inclinado para frente;
- controlar o sangramento através de compressão digital por 5 a 10 min;
- aplicar compressa gelada no dorso nasal, se disponível.

O que não fazer:

- Deixar a vítima assoar o nariz;
- introduzir qualquer instrumento na narina, pois isso poderá empurrar o corpo estranho ainda mais para dentro ou provocar rompimento dos vasos.
- Nunca inclinar a cabeça da vítima para trás.

Para onde encaminhar: Se necessário encaminhar para o Ambulatório Médico do Campus ou Serviço de Saúde mais próximo para avaliação e conduta profissional.

6. Desmaio

Causas: Podem levar ao desmaio ambientes cheios, sem ventilação adequada, emoções fortes, insolação, dor intensa, falta de alimentação etc.

Sinais e sintomas:

- Palidez;
- Suor frio;
- Fraqueza;
- Tontura;
- Visão turva e escura;
- Pulso rápido e fraco
- Podendo perder a consciência.

O que fazer (Conduta): Colocar a vítima em decúbito dorsal (deitada), com os pés ligeiramente elevados e orientar a vítima para respirar profundamente.

- Proporcionar ambiente arejado;
- Virar a cabeça para o lado;
- Afrouxar roupas e cinto;
- CONTROLAR a respiração, após retorno à consciência;
- Colocar a vítima sentada, devagar, segurando-a.

O que não fazer:

- Deixar a vítima levantar-se repentinamente, pois isso pode ocasionar um novo desmaio.
- NÃO dê líquidos à vítima logo após retomar a consciência.

Para onde encaminhar: Se necessário encaminhar para o Ambulatório Médico do Campus ou Serviço de Saúde mais próximo para avaliação e conduta profissional.

7. Crise Convulsiva

Causas: Epilepsia, hipoglicemia, overdose, abstinência alcoólica, meningite, lesões cerebrais, febre alta principalmente em crianças.

Sinais e sintomas:

- Súbita perda da consciência, acompanhada de contrações musculares involuntárias, cianose, salivação intensa, lábios e dentes cerrados.
- Eventual liberação esfinteriana caracterizada por incontinência fecal e urinária.
- Na fase **pós-convulsiva**: sonolência, confusão mental, agitação, flacidez muscular e cefaleia, sinais de liberação esfinteriana.

O que fazer (Conduta):

- Deixar a vítima deitada e afastar tudo o que puder machucá-la.
- Retirar de seu corpo objetos que possam sufocar e machucar.
- Dar espaço para a vítima respirar.
- Afrouxar as roupas e deixar que ela se debata até os movimentos pararem.
- Colocar um pano ou almofada sob a cabeça da vítima para que ela não se machuque.
- Não tentar abrir a boca da vítima.
- Anotar sempre a frequência, a duração e as características da crise, quando presenciadas ou obter junto aos circundantes e/ou testemunhas;
- Permaneça ao lado da vítima e chame socorro especializado, caso a convulsão dure mais que quatro minutos.

(Após a convulsão)

- Lateralizar a cabeça para que a saliva escorra evitando engasgo.
- Limpar as secreções salivares com um pano ou papel para facilitar a respiração.
- Observar se a respiração está adequada.
- Se a vítima dormir, deixe-a na posição de decúbito lateral.
- Chamar socorro especializado, ou encaminhá-la para o atendimento médico.

O que não fazer: Nunca tente puxar a língua da vítima com a mão. Nunca dê medicamentos para a vítima.

Para onde encaminhar: Encaminhar para o Ambulatório Médico do Campus ou Serviço de Saúde mais próximo para avaliação e conduta profissional.

8. Queimaduras

Causas: Lesão na pele provocada geralmente pelo calor, mas também pode ser provocada pelo frio, eletricidade, produtos químicos, radiações e até fricções.

Sinais e sintomas: Dor aguda no local, Ardência, vermelhidão, bolhas.

O que fazer (Conduta):

- Resfriar o local com muita água corrente.
- Secar o local, sem esfregar, após 5 minutos ou até diminuir a dor;
- Cobrir com compressa limpa sem apertar o local;
- Encaminhar ao médico, principalmente nos casos de queimadura moderada ou grave.

O que não fazer:

- Não usar gelo;
- Não use cremes hidratantes, pasta dental, antissépticos ou manteiga.
- Se houver formação de bolhas, não perfure ou mexa nelas.

Queimaduras químicas (pele e olhos)

- Devem ser lavados com água corrente, sem esfregar, até que todos os resíduos sejam retirados.
- Se algum produto cair nos olhos, tente manter as pálpebras da vítima abertas e jogue água corrente sobre o globo ocular afetado. Isto pode ser feito com chuveirinho ou sob uma torneira. Esta lavagem do globo ocular deve ser feita por 20 minutos, pois algumas substâncias como a cal, são extremamente agressivas e demoram a ser removidas.
- Tome cuidado para que esta lavagem não atinja o olho não acometido. Água corrente não causa danos e ainda pode salvar da cegueira. Mas, atenção: não use jatos, para evitar o deslocamento da córnea.

Para onde encaminhar: Se necessário encaminhar para o Ambulatório Médico do Campus ou Serviço de Saúde mais próximo para avaliação e conduta profissional.

9. Envenenamento e Intoxicações

Causas:

- Ingestão de qualquer tipo de substância tóxica, química ou natural - **via Oral (Boca)**;
- Contato direto com plantas ou substâncias tóxicas - **via cutânea (Pele)** ou;
- Aspiração de vapores ou gases emanados de substâncias tóxicas - **via respiratória (Inalação)**.

Sinais e sintomas:

- Sinais evidentes, na boca ou na pele, de que a vítima tenha mastigado, engolido, aspirado ou estado em contato com substâncias tóxicas;
- Hálito com odor estranho (cheiro do agente causal no hálito);
- Modificação na coloração dos lábios e interior da boca, dependendo do agente causal.
- Dor, sensação de queimação na boca, garganta ou estomago.
- Sonolência, confusão mental ou outras alterações de consciência.
- Vômitos.
- Lesões cutâneas, queimaduras ou bolhas.
- Depressão da função respiratória.
- Convulsões.
- Queda de temperatura, que se mantém abaixo do normal.
- Paralisia.

O que fazer (Conduta):

Intoxicação cutânea (pele)

- Retire as roupas que estejam em contato com a substância.
- Lave bem a pele contaminada com água corrente e sabão, por no mínimo 10 minutos;
- No caso de contaminação nos olhos, lave-os bem com água corrente por 15 minutos.
- Procure o serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou embalagem do agrotóxico.

Inalação pela respiração

- Remova a vítima para local fresco e ventilado;
- Afrouxe as roupas;
- Avaliar presença de pulso e respiração;

-
- Acionar serviço de Emergência SAMU 192

Intoxicação Oral

- Leia o rotulo do produto para ver se e recomendado provocar vomito;
- Quando recomendado, provoque vomito baixando bem a cabeça do intoxicado e pressionando a base da língua com o cabo de uma colher ou objeto similar;
- Limpar a boca dos restos das substâncias;
- Remover roupas contaminadas;
- Identificar com rotulo ou nome da substância ingerida, aspirada ou impregnada.
- Procure o serviço de saúde mais próximo, levando o rótulo ou embalagem do agrotóxico.

O que não fazer:

- Não dê leite ou água para a vítima.
- Não provocar vômito se a vítima estiver sem consciência, em convulsão ou tiver ingerido substâncias corrosivas e irritantes, tais como: soda cáustica; ácidos; alvejantes de uso doméstico; amoníaco; produtos derivados do petróleo.

Para onde encaminhar: Acionar o Serviço de Emergência SAMU 192 e/ou encaminhar a vítima ao Hospital o mais breve possível;

10. Engasgo ou Asfixia

Causas: Obstrução das vias aéreas por corpos estranhos.

Sinais e sintomas: Engasgo com tosse e/ ou sinais de sufocação

- **Obstrução leve (Parcial):** Paciente capaz de responder se está engasgado. Consegue tossir, falar e respirar.
- **Obstrução grave (Total):** Paciente consciente e que não consegue falar. Pode não respirar ou apresentar respiração ruidosa, tosse silenciosa e/ou inconsciência.

O que fazer: (Conduta):

- **Obstrução leve em paciente responsivo:** Não realizar manobras de desobstrução (não interferir); acalmar o paciente; incentivar tosse vigorosa; acionar o serviço médico de emergência (SAMU 192) e observar atento e constantemente.
- Se evoluir para **obstrução grave em paciente responsivo:** Acionar o serviço médico de Emergência SAMU 192 e iniciar a manobra de *heimlich*: posicionar-se por trás do paciente, com seus braços à altura da crista ilíaca; posicionar uma das mãos fechada, com a face do polegar encostada na parede abdominal, entre apêndice xifóide e a cicatriz umbilical; com a outra mão espalmada sobre a primeira, comprimir o abdome em movimentos rápidos, direcionados para dentro e pra cima (em j);
- Repetir a manobra até a desobstrução, chegada do SAMU ou se o paciente tornar-se “não responsivo”.

Para onde encaminhar: Acionar o Serviço médico de Emergência SAMU 192 imediatamente.

11. Suspeita de entorse, luxação ou fratura

Entorse

Causas: ocorre quando a articulação é subitamente movimentada além de sua amplitude normal. Os ligamentos são estirados e podem sofrer ruptura total ou parcial.

Sinais e sintomas: Dor; Inchaço; Deformidade; Descoloração da pele Incapacidade de usar a parte afetada normalmente;

O que fazer (Conduta):

- Não permita que a vítima use/apoie a parte/articulação afetada. Imobilize a articulação. Qualquer movimento aumenta a circulação de sangue para o local, o que aumenta o inchaço;
- Aplique Gelo: o frio alivia a dor e previne o inchaço e inflamação. Cubra imediatamente a área lesionada com bolsas de gelo, ou toalhas frias ou mergulhe a área em água gelada por 20 ou 30 min a cada 2 ou 3 horas. Proteja a pele do gelo com um pano ou saco plástico para evitar uma queimadura.
- Faça bandagem ao redor da área lesionada: limita o sangramento interno e comprime os fluidos provenientes do local da lesão. Usar por 24 horas (exceto durante a aplicação do gelo). As bandagens devem ser aplicadas com firmeza, mas sem apertar, para prevenir insuficiência circulatória. Ao enfaixar qualquer membro ou região afetada, deve ser deixada uma parte ou extremidade à mostra para observação da normalidade circulatória. Caso haja ferida no local da entorse, cobrir com curativo seco e limpo, antes de imobilizar e enfaixar.
- Eleve a área ao nível do coração ou um pouco acima.

O que não fazer: bandagem muito apertada limitando a circulação do membro afetado; aplicar gelo diretamente na pele.

Para onde encaminhar: Acione o SAMU 192 ou encaminhar para atendimento hospitalar ou PSF mais próximo.

Luxação:

Causas: articulação que é deslocada de seu lugar.

Sinais e Sintomas:

- Dor intensa no local afetado (a dor é muito maior que na entorse), geralmente afetando todo o membro cuja articulação foi atingida.
- Edema.
- Impotência funcional.
- Deformidade visível na articulação. Podendo apresentar um encurtamento ou alongamento do membro afetado.

O que fazer (Conduta):

- Não permita que a vítima use/apoie a parte/articulação afetada.
- Colocar uma compressa fria ou bolsa de gelo no local do deslocamento. Manter a vítima calma aquecida, quieta e na posição mais confortável.

O que não fazer: Não tente corrigir o deslocamento.

Para onde encaminhar: Acione o SAMU 192 ou encaminhar para atendimento hospitalar ou PSF mais próximo.

Fratura:

Causas: É uma interrupção na continuidade do osso. Ocorre geralmente devido à queda, impacto ou movimento violento com esforço maior que o osso pode suportar. As fraturas podem ser:

- Abertas ou expostas, quando a pele é rompida e é possível ver o osso;
- Fechadas ou simples, quando a pele não se rompe.

Sinais e Sintomas

- Dor intensa no local afetado;
- Edema;
- Impotência funcional.
- Apresentam aparência geralmente deformante devido ao grau de deformação que podem impor à região afetada. A deformidade óssea pode ser visível (quando a pele é rompida e é possível ver o osso ou quando a pele não se rompe).

O que fazer (Conduta):

- Não permita que a vítima use/apoie a região afetada.
- Se possível, imobilize provisoriamente a região acometida na posição encontrada, para evitar a movimentação dos fragmentos ósseos;
- Em caso de fraturas expostas e caso haja hemorragia, é necessário tentar controlá-la com um pano limpo, que deve ser colocado sobre o local e pressionado;
- Em caso de fraturas na região das costas e pescoço, a movimentação só deve ser feita por profissionais especializados.

O que não fazer: Não tente colocar o osso no lugar, pois isso pode agravar o quadro.

- Não deslocar, remover ou transportar o acidentado de fratura, antes de ter a parte afetada imobilizada corretamente por um especialista.
- A única exceção a ser feita é para os casos em que o acidentado corre perigo iminente de vida.

Para onde encaminhar: Acione o SAMU 192 ou encaminhar para atendimento hospitalar ou PSF mais próximo.

12. Distensão muscular (estiramento muscular)

Causas: Envolvem o estiramento e/ou a ruptura de fibras musculares. Os músculos são forçados além de seu alcance normal ou quando músculos não aquecidos ou tensos são exercitados subitamente.

Sinais e sintomas: inchaço rápido e acentuado. Pode ocorrer rompimento de vasos sanguíneos formando hematoma. O local fica roxo, inchado e dolorido.

O que fazer (Conduta):

- coloque a vítima em uma posição confortável que retire a pressão sobre os músculos distendidos. Manter a parte contundida em repouso.
- aplique compressa fria ou gelo, sobre a pele protegida por um pano limpo ou gaze para evitar queimaduras.

O que não fazer: não coloque compressa ou bolsa de água quente.

Para onde encaminhar: Se a dor persistir ou for muito intensa deve-se procurar atendimento médico

13. Cãibras

Causas: Não se sabe exatamente, mas sabe-se que a temperaturas baixas pode contribuir para seu aparecimento; também é sinal de desidratação e podem ocorrer depois da atividade física, quando perde-se muitos eletrólitos (pela transpiração excessiva).

Sinais e sintomas: Espasmos musculares incontroláveis;

O que fazer (Conduta): Faça a vítima estender delicadamente o músculo afetada; aplique pressão firme e estável no músculo que sofreu a câimbra usando a parte superior da palma da mão. Coloque bolsa de gelo sobre o músculo afetado. Se ocorrer durante ou após a atividade física intensa, faça a vítima ingerir uma bebida eletrolítica ou um copo de água levemente salgada.

O que não fazer: massagem na região afetada; tomar relaxante muscular.

Para onde encaminhar: Não necessita de atendimento médico de urgência ou emergência. Caso ocorra com frequência, procure atendimento médico.

14. Traumas por quedas ou pancadas

Causas geralmente é causada por um acidente com queda após um tropeço, trombada, pancada (impacto).

Sinais e sintomas: dor, equimoses, contusões, escoriações e outras lesões.

O que fazer (Conduta): Aplicar gelo (envolvido em um pano ou compressa) no local por 10 a 20 minutos; aplicar pomada para dor e friccionar.

O que não fazer: Não aplicar compressa de calor.

Para onde encaminhar: Se necessário encaminhar para o Ambulatório Médico do Campus ou Serviço de Saúde mais próximo para avaliação e conduta profissional.

OBS.: Alguns impactos podem soltar ou quebrar um ou mais dentes:

- Quando o dente apresenta movimento, deve-se morder uma gaze com firmeza para manter o dente na cavidade e procurar imediatamente o dentista.
- Quando o dente cair, deve-se enxaguar a boca com água morna para remover o sangue ou outro tipo de sujeira, e colocar uma gaze enrolada no local.
- Colocar o dente no leite gelado ou dentro da boca da vítima, pois a saliva protegerá o dente, e procurar o dentista imediatamente.
- Quando o dente estiver quebrado, deve-se levar o pedaço do dente até o dentista.

15. Acidentes por animais peçonhentos

Causas: animais que possuem presas, ferrões, cerdas, espinhos (entre outros), podem envenenar as vítimas. São exemplos de animais peçonhentos as serpentes, aranhas, escorpiões, lacraias, taturanas, vespas, abelhas, marimbondos e formigas. Entre as serpentes peçonhentas encontradas no Brasil estão: a cascavel, as jararacas, a surucucu e a coral-verdadeira.

Sinais e sintomas:

- dor aguda no local; vermelhidão; coceira; inchaço;
- náuseas ou vômito;
- suor excessivo; agitação; tremores; salivação;
- aumento dos batimentos cardíacos e da pressão arterial.

O que fazer (Conduta):

- Procure atendimento médico imediatamente.
- Informe ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal, como: tipo de animal, cor, tamanho, entre outras.
- Acalmar a vítima;
- Em acidentes nas extremidades do corpo, como braços, mãos, pernas e pés, retire acessórios que possam levar à piora do quadro clínico, como anéis, fitas amarradas e calçados apertados.
- Se possível, e caso tal ação não atrase a ida do paciente ao atendimento médico, lave o local da picada com água e sabão, mantenha a vítima em repouso e com o membro acometido elevado até a chegada ao pronto socorro.

O que não fazer:

- Não amarre (torniquete) o membro acometido e, muito menos, corte e/ou aplique qualquer tipo de substância (pó de café, álcool, entre outros) no local da picada.
- Não tente “chupar o veneno”, isso aumenta as chances de infecção local.
- Não tente remover o ferrão da abelha com pinças, pois esse procedimento resulta na inoculação do veneno ainda existente no ferrão;
- Não faça, em hipótese alguma, torniquete ou garrote; não fure, corte, esprema ou faça sucção no local da picada; não coloque folhas, pó de café, pomadas, fumo no local da picada; não tome nem aplique bebidas alcoólicas no local.

Para onde encaminhar: Acione o SAMU 192 ou encaminhar para atendimento hospitalar mais próximo.

16. Mordida de Animais

Causas: mordida por animais domésticos ou de rua (geralmente cães).

Sinais e sintomas: dor, edema, sangramento, perfuração.

O que fazer (Conduta):

- Lavar a área acometida com água corrente e sabão, com vigor.
- Manter compressa com pano limpo, comprimindo a ferida. Se possível, prender o animal para observação. Interrogar sobre vacinação do animal.

O que não fazer: não tente matar o animal.

Para onde encaminhar: encaminhar para o Serviço de Saúde mais próximo (PSF) ou atendimento hospitalar para avaliação e conduta profissional.

17. Referências Bibliográficas:

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. **Protocolos de Intervenção para o SAMU 192 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência**. Brasília: Ministério da Saúde, 2016.

HAFEN, Brent Q., FRANDSEN, Kathryn J., KARREN, Keith J. **Guia de primeiros socorros para estudantes**. 7. ed. São Paulo: Manole, 2002.



Há 53 anos
trilhando caminhos e
transformando vidas!



www.bambui.ifmg.edu.br

 IFMG Campus Bambuí

 @ifmg.bambui